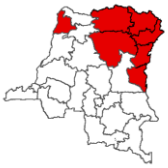
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°156 /MVE-BDBV/17/10/2026

Date du rapport : 17 octobre 2026 Date de publication : 18 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Une évolution encourageante de la situation épidémiologique est observée, avec 40 nouveaux cas confirmés contre 67 la veille (−40,3 %) et 64 au 10 octobre (−37,5 %). Ces cas proviennent de l'Ituri (27), du Nord-Kivu (9), du Haut-Uélé (2) et de la Tshopo (2). Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée.
- Les décès communautaires diminuent à 9, contre 18 la veille (−50,0 %) et 13 au 10 octobre (−30,8 %). Toutefois, 16 décès ont été enregistrés dans les CTE, contre 8 aux deux dates de comparaison, nécessitant un renforcement de la prise en charge.
- La positivité biologique recule à 9,7 %, contre 14,4 % au 10 octobre (−4,7 points). Au total, 411 échantillons ont été analysés, dont 40 positifs, traduisant une évolution favorable à consolider par le renforcement de la surveillance et des interventions de

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
9455	4 561	48,2 %	925	2 530	80,0%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi et Nord Ubangi

66 Zones de santé touchées sur 178 (37,1%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Une évolution encourageante de la situation épidémiologique est observée au 17 octobre 2026, avec 40 nouveaux cas confirmés, contre 67 la veille (−40,3 %) et 64 au 10 octobre (−37,5 %). Ces cas proviennent de l'Ituri (27), du Nord-Kivu (9), du Haut-Uélé (2) et de la Tshopo (2). Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée.

Les décès communautaires diminuent à 9, contre 18 la veille (−50,0 %) et 13 au 10 octobre (−30,8 %). Toutefois, 16 décès ont été enregistrés dans les CTE, portant à 25 le total des décès du jour, contre 26 la veille (−3,8 %).

Par ailleurs, 8 patients ont été déclarés guéris, dont 7 en Ituri et 1 au Nord-Kivu, portant le cumul national à 2 530 guérisons.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule 9 455 cas confirmés et 4 561 décès, soit une létalité de 48,2 %. L'Ituri demeure l'épicentre, concentrant 73,2 % des cas cumulés et 67,5 % des nouveaux cas. Au total, 66 zones de santé sur 178 (37,1 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées et **12 ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé et 6 ZS** se retrouvent entre **22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé**. Cependant, **269 PPL** ont été touchés par la MVE BDB_17. La répartition des PPL sont répartis de la manière suivante : Bas-Uele (1), Haut-Uele (31), Ituri (180), Nord-Kivu (45) et Tshopo (12).

La baisse des nouveaux cas et des décès communautaires constitue un progrès à consolider, notamment par le renforcement de la surveillance, de la détection précoce et de la prise en charge dans les CTE.

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 17 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées
Ituri	27	6 918	3 197	46,2 %	28/36 (77,8 %)	25/36 (69,4 %)
Nord-Kivu	9	2 036	1 156	56,8 %	17/34 (50,0 %)	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	2	408	176	43,1 %	7/13 (53,8 %)	7/13 (53,8 %)
Tshopo	2	73	25	34,2 %	7/23 (30,4 %)	5/23 (21,7 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34 (0,0 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8 %	4/11 (36,4 %)	4/11 (36,4 %)
Sud-Ubangi	0	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16 (6,3 %)
Nord-Ubangi	0	2	1	50,0 %	1/11 (9,1 %)	1/11 (9,1 %)
TOTAL	**40**	**9 455**	**4 561**	**48,2 %**	**66/178 (37,1 %)**	58/178 (32,8%)

COMMENTAIRES :

- La notification quotidienne recule de 64 à 40 cas entre le 10 et le 17 octobre (−37,5 %).
- La létalité nationale passe de 48,3 % à 48,2 % (−0,1 point). L'Ituri demeure l'épicentre avec 27 des 40 nouveaux cas (67,5 %).
- Le cumul atteint 9 455 cas et 4 561 décès dans huit provinces. Les zones de santé historiquement touchées passent de 65 à 66, avec l'extension au Nord-Ubangi.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 17 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6918**	**3197**	**46,2%**	**27**	**5**	**12**	**17**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	11	6	54,5%	1	0	0	0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	216	48	22,2%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1881	628	33,4%	4	2	1	3
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	188	113	60,1%				0
Lita	309	156	50,5%	1	0	0	0
Logo	14	9	64,3%	0	0	1	1
Lolwa	36	9	25,0%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	68	28	41,2%				0
Mandima	330	165	50,0%	14	2	7	9
Mangala	379	162	42,7%				0
Mongbwalu	713	342	48,0%				0
Nia-Nia	330	191	57,9%	1	1	0	1
Nizi	827	298	36,0%	3	0	0	0
Nyankunde	134	40	29,9%			1	1
Rimba	19	5	26,3%				0

Rwampara	1160	402	34,7%	3	0	2	2
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**2036**	**1156**	**56,8%**	**9**	**4**	**2**	**6**
Beni	506	341	67,4%	4	2		2
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	311	187	60,1%				0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	76	29	38,2%				0
Katwa	639	392	61,3%	0	0	1	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	44	21	47,7%				0
Lubero	35	14	40,0%				0
Mabalako	74	30	40,5%	4	2		2
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	15	5	33,3%				0
Masereka	39	13	33,3%				0
Musienene	151	71	47,0%				0
Mutwanga	24	5	20,8%				0
Oicha	50	22	44,0%	1	0	1	1
Vuhovi	40	14	35,0%				0
Haut-Uélé	**408**	**176**	**43,1%**	**2**	**0**	**2**	**2**
Boma Mangbetu	45	19	42,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	106	46	43,4%	1	0	0	0
Pawa	102	55	53,9%	0	0	2	2
Rungu	5	3	60,0%				0
Wamba	146	51	34,9%	1	0	0	0
Tshopo	**73**	**25**	**34,2%**	2	0	0	0
Bafwasende	17	2	11,8%				0
Kabondo	9	1	11,1%	1	0	0	0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	33	14	42,4%	1	0	0	0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Wapinda	2	1	50,0%				0
Total	**9455**	**4561**	**48,2%**	**40**	**9**	**16**	**25**

COMMENTAIRES :

- Évolution favorable de l'épidémie : 40 nouveaux cas confirmés contre 67 la veille (−40,3 %) et 64 au 10 octobre (−37,5 %). Les décès communautaires diminuent à 9 contre 18 la veille (−50,0 %).
- L'Ituri demeure l'épicentre, concentrant 67,5 % des nouveaux cas, principalement à Mandima (14 cas), tandis que Beni et Mabalako enregistrent chacune 4 cas au Nord-Kivu.
- La létalité nationale s'établit à 48,2 %, avec 9 455 cas confirmés et 4 561 décès cumulés. Toutefois, les 16 décès intra-CTE, contre 8 la veille, appellent au renforcement de la prise en charge.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 17 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	125	8	133	104	8	21	0	112	1
Bas Uélé	130	0	130	18	0	112	0	18	0
Ituri	1 347	73	1 420	119	71	1 220	2	182	61
Nord-Kivu	793	29	822	99	29	694	0	128	86
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	153	1	154	9	1	144	0	10	3
Total Général	**2 548**	**111**	**2 659**	**349**	**109**	**2 191**	**2**	**450**	**151**

Commentaires :

- Performance de la surveillance : 2 659 alertes ont été reçues, dont 458 validées comme cas suspects (17,2 %), traduisant une mobilisation importante du dispositif d'alerte, particulièrement en Ituri (53,4 %) et au Nord-Kivu (30,9 %).
- Investigation des cas suspects : 450 suspects sur 458 ont été investigués, soit 98,3 %, témoignant d'une bonne réactivité des équipes. Toutefois, 8 suspects restent à investiguer, principalement en Ituri.
- Prise en charge : 151 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE, soit 33,6 % des suspects investigués, principalement au Nord-Kivu (86) et en Ituri (61).

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

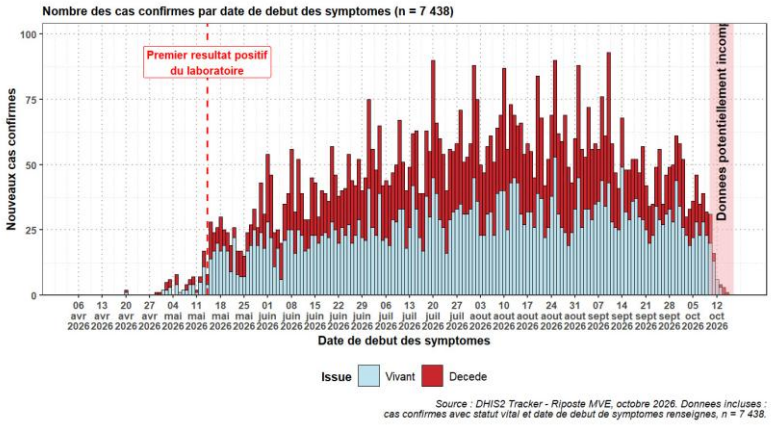
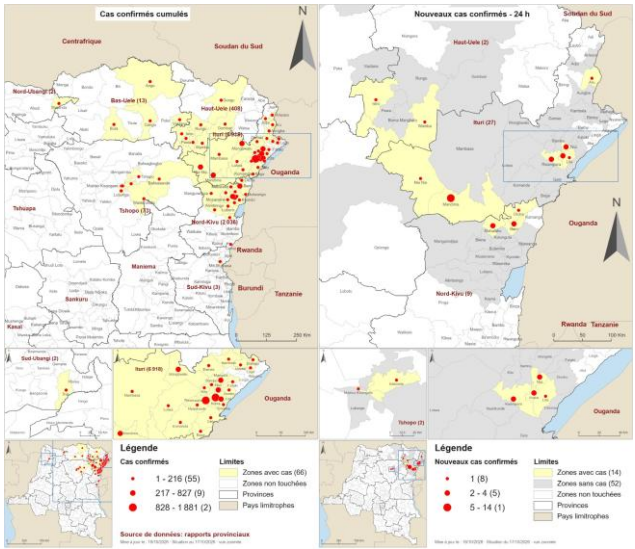


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Poursuite de l'appui et du suivi des activités de riposte dans les provinces affectées, à travers les différents piliers techniques, en vue de renforcer la coordination opérationnelle et l'efficacité des interventions ;
- Poursuite de la mission de terrain de la Coordination nationale de la riposte, conduite par l'Incident Manager (IM), dans la province du Nord-Kivu, notamment à Beni, Butembo et Kalunguta, afin d'évaluer la situation épidémiologique, de suivre les performances des interventions, d'identifier les gaps opérationnels et de renforcer l'encadrement des équipes de terrain ;
- Renforcement des échanges avec les autorités sanitaires provinciales, les équipes cadres des zones de santé, les responsables des piliers techniques et les partenaires, en vue d'harmoniser les interventions et d'accélérer la résolution des difficultés opérationnelles ;
- Tenue d'une réunion de crise consacrée à l'évolution de la situation épidémiologique dans la province du Nord-Ubangi, à la suite de la notification des cas confirmés dans la zone de santé de Wapinda, en vue d'évaluer les risques de propagation, d'identifier les besoins urgents et de définir les mesures prioritaires pour une riposte rapide et coordonnée ;
- Mobilisation des partenaires techniques et financiers, notamment pour le renforcement des investigations épidémiologiques, de la recherche et du suivi des contacts, du diagnostic biologique, de la prise en charge, de la PCI et de l'engagement communautaire au Nord-Ubangi, avec la perspective du redéploiement des équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) depuis le Sud-Ubangi ;
- Identification et priorisation des besoins opérationnels en ressources humaines, logistique, mobilité, équipements et capacités d'accueil dans les CT/CTE, afin d'améliorer la réactivité des équipes de riposte.

1.2. Défi majeur

Nécessité d'une mobilisation rapide des ressources pour contenir l'extension de l'épidémie au Nord-Ubangi, tout en maintenant l'intensité des interventions dans les foyers actifs de l'Ituri et du Nord-Kivu et en assurant le suivi effectif des orientations de la Coordination nationale.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au cours de la journée du 17 octobre 2026, 2 659 alertes ont été rapportées dans les cinq provinces ayant transmis leurs données : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Bas-Uélé et Tshopo. Parmi ces alertes, 2 651 (99,7 %) ont été vérifiées, dont 458 (17,3 %) validées comme cas suspects et 2 193 (82,7 %) invalidées. Sur les 458 cas suspects validés, 450 (98,3 %) ont été investigués, dont 151 (33,6 %) transférés vers les CT/CT

Parmi les 35 162 contacts à suivre dans les six provinces ayant transmis leurs données, 28 144 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 80,0 %, en légère hausse par rapport à la veille (79,1 %) mais inférieur au seuil requis de 95,0 %. Ce taux était de 100,0 % (44/44) au Sud-Ubangi, 93,0 % (749/805) au Bas-Uélé, 90,4 % (1 358/1 503) au Haut-Uélé, 82,8 % (995/1 202) à la Tshopo, 81,3 % (14 563/17 923) au Nord-Kivu et 76,3 % (10 435/13 685) en Ituri, où le suivi reste particulièrement faible à Bunia (27,7 % ; 1 004/3 620) et à Nia-Nia (57,1 % ; 220/385) ; au Nord-Kivu, il n'est que de 0,0 % (0/215) à Manguredjipa, 53,0 % (157/296) à Kyondo et 58,5 % (741/1 267) à Mabalako, et au Haut-Uélé de 79,3 % (130/164).

2.1.2. Défi majeur

Atteindre au moins 95 % de suivi des contacts et 100 % d'investigation des cas suspects, grâce au renforcement de la supervision de proximité, de la mobilité des équipes et de la coordination opérationnelle dans les zones de santé sous-performantes.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Le 17 octobre 2026, 5 alertes ont été notifiées aux PoE/PoC des cinq provinces suivies : 2 en Ituri (PoC DGRPI Nizi et Biakato Mayi), 1 au Nord-Kivu (PoC Foner Kasindi), 1 au Sud-Kivu (PoE de Kavimvira) et 1 au Haut-Uélé (PoC Mutowamba). Elles comprennent 3 alertes vivantes validées comme cas suspects (2 en Ituri et 1 au Nord-Kivu), dont 2 (66,7 %) ont été transférées vers les CT/CTE ou référées vers une structure de soins, le suspect de Biakato Mayi ayant refusé son transfert, 1 corps sans vie intercepté et swabé au PoE de Kavimvira (Sud-Kivu) et 1 alerte invalidée après examen au Haut-Uélé.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 17 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,4% (60/61)	95,2% (20/21)	55,6% (5/9)	100,0% (18/18)	90,0% (9/10)	94,1% (112/119)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	ND	100%	90%	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	138 695	91 827	7 760	20 297	24 599	283 178
% des voyageurs screenés	97,3%	97,9%	98,6%	98,9%	99,5%	97,8%
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,9%	97,9%	98,6%	98,5%	99,5%	97,6%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	97,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%
Nombre d'alertes notifiées	2	1	1	0	1	5
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	1	0	0	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	1	0	0	1
% des cas suspects transférés au CTE/CT	50,0%	100,0%	NA	NA	NA	66,7%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	100,0%	NA	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	NA	NA	100,0%

2.2.2. Défis

Assurer la référence de 100 % des cas suspects détectés aux PoE/PoC, tout en renforçant la sensibilisation des voyageurs, la surveillance des mouvements de population et la gestion des refus de transfert.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 27 nouveaux résultats positifs** (22 vivants et 5 décès) sur 165 échantillons reçus et analysés **(positivité : 16,4%) ;**
- **Nord-Kivu : 9 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 4 décès) sur 185 échantillons reçus et analysés **(positivité : 4,9%) ;**
- **Haut-Uélé : 2 nouveaux résultats positifs (**2 vivants et 0 décés) **sur 30 échantillons reçus et analysés (positivité : 6,7%) ;**
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs (**2 vivants et 0 décés) **sur 12 échantillons reçus et analysés (positivité : 16,7%) ;**

- **Bas Uélé :** 19 nouveaux échantillons reçus au laboratoire de Buta et Isiro analysés tous négatifs.

2.3.2. Défi majeur

Garantir un diagnostic biologique rapide, fiable et accessible dans toutes les zones affectées, en renforçant les capacités des laboratoires, la disponibilité des intrants et le transport sécurisé des échantillons.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 27 rings ont été ouverts sur 35 (77,1 %), 45 ménages décontaminés sur 58 (77,6 %) et 4 FOSA décontaminées sur 5 (80,0 %). Sur 89 alertes EDS, 74 EDS ont été réalisés (83,1 %) et 65 corps swabés sur 79 (82,3 %) ;
- **Tshopo** : 10 ESS ont été suivis dans 4 ZS et 169 prestataires briefés sur les précautions standards, le triage et le screening ; le score PCI du CS Mbilinga a été réévalué à 43,5 %, le CS Kumbasika a été doté en intrants PCI, les PPL de la Polyclinique Rekapi ont été évalués autour d'un cas confirmé (5 à haut risque et 10 à risque intermédiaire) et le ménage du 64e cas confirmé a été décontaminé ; 2 EDS ont été manqués à Rekapi 1 ;
- **Haut-Uélé :** 1 ring a été ouvert sur 1 (100 %), 3 ménages sur 3 et 2 ESS sur 2 ont été décontaminés à Pawa, dont la clinique Libiki, et le CTE de Pawa a été décontaminé autour des cas confirmés ; 232 élèves ont été briefés sur l'hygiène des mains à l'école Mgr Olombe lors de la journée internationale de l'hygiène des mains et les scores PCI de 15 ESS de Pawa, réévalués, vont de 20 % au PS La Providence à 80 % au CH Nebobongo. Sur 2 alertes EDS, 1 EDS a été réalisé et 1 corps swabé dans l'AS d'Abiangama, l'autre étant en cours à Gatoa ;
- **Nord-Kivu :** 22 rings ont été ouverts sur 31 (71,0 %), 10 ménages décontaminés sur 20 (50,0 %) et 14 ESS sur 17 (82,4 %) ; 10 ESS ont été évalués (score PCI moyen de 41,1 %), 153 ESS suivis et 317 prestataires briefés, et 2 PPL sur 3 évalués sont à haut risque à Oicha, sans PPL infecté parmi les cas confirmés du jour. Sur 58 alertes EDS reçues et 44 reports de la veille, 55 EDS ont été réalisés et 58 corps swabés, sans échec de prélèvement ; 47 EDS sont reportés au lendemain ;
- **Bas-Uélé** : les prestataires de 7 ESS ont été suivis dans 4 ZS (Buta 2/2, Koteli 1/1, Viadana 1/1 et Ganga 3/3), et 25 prestataires et 4 hygiénistes ont été briefés (100 %) sur le port des EPI, la gestion des déchets et le triage ; les DLM sont fonctionnels à l'HGR de Koteli (3/3), au CS Rive gauche (1/1) et au CH Rubi Lisanga (3/3), seul le triage du CS Rive gauche est fonctionnel et le CS Kavio a obtenu un score PCI de 17 % ; aucune alerte EDS n'a été notifiée et 1 ménage et 1 ESS restent à décontaminer à Dakwa.

2.4.2. Défis

Renforcer la couverture et la qualité des interventions PCI/EDS, assurer la réalisation rapide et sécurisée des enterrements, améliorer les performances PCI des structures sanitaires et garantir la protection des prestataires de première ligne afin de réduire les risques de transmission nosocomiale et communautaire.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 114 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 101 sorties : 7 guérisons. Ainsi, 393 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation de 38 %, dont 45 malades critiques ; 16 patients ont été évacués par ambulance, 374 patients sur 382 (98 %) ont reçu des repas chauds et 76 enfants sont sous LNPE/SLM (11 au CTE, 4 à la crèche et 61 dans la communauté) ;
- **Au Nord-Kivu**, 50 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 62 sorties : 1 guérison (Masereka). Ainsi, 471 patients sont hospitalisés, dont 2 malades critiques, pour un taux d'occupation des CTE/CTde 85,1 % : (349/410), de 92,7 % pour les suspects (178/192) et de 78,4 % pour les confirmés (171/218) ; 122 patients (26 %) sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT. 11 courses d'ambulance ont été réalisées avec succès (8

ambulances sur 14 utilisées) et 177 confirmés, 194 suspects, 419 PPL et 197 accompagnants ont reçu des repas chauds **;**

- **Au Haut-Uélé**, 2 décès de cas confirmés ont été enregistrés au CTE de Pawa, d'où 2 non-cas sont également sortis ; 39 cas confirmés restent hospitalisés. Les données d'admissions et d'occupation des lits du 17 octobre n'ont pas été transmises ;
- **À la Tshopo,** 2 nouvelles admissions de suspects ont été enregistrées au CTE de Météo contre 1 sortie (évasion), sans guérison ni décès. Ainsi, 19 patients sont hospitalisés pour 36 lits, soit un taux d'occupation de 52,8 % ; 6 cas confirmés de Bafwasende sont perdus de vue. Depuis le début, 44 cas confirmés ont reçu le traitement expérimental (3 MBP134 et 41 Remdesivir) et 464 personnes la prophylaxie post-exposition ;
- **Au Bas-Uélé**, aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré ; 3 patients restent en isolement, sans guérison ni décès notifié.

2.5.2. Défis

Renforcer rapidement les capacités d'accueil et la qualité des soins dans les CT/CTE, particulièrement au Nord-Kivu, garantir la prise en charge sécurisée des patients hospitalisés hors des structures dédiées, améliorer la disponibilité des ambulances et assurer le suivi exhaustif des patients afin de réduire la mortalité et les risques de transmission communautaire et nosocomiale.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri,** la vaccination des PPL par l'Ervebo et les activités de recherche sur l'efficacité du vaccin contre la MVE-BDBV se poursuivent ; le cumul des PPL vaccinés atteint 1 260 (515 femmes et 745 hommes, dont 15 femmes enceintes et 30 femmes allaitantes), avec 26 MAPI non graves et 2 MAPI graves notifiées ;
- **Au Nord-Kivu,** 130 PPL ont été vaccinés le 17 octobre 2026 dans la ZS de Beni, portant le cumul à 192 PPL vaccinés sur une cible de 7 105 (2,7 %) ; 600 doses de vaccin Ervebo et 600 seringues ont été réceptionnées et les PPL de l'AS Mabakanga ont été sensibilisés sur la vaccination contre la MVE. **Au Haut-Uélé,** le cumul des PPL vaccinées par l'Ervebo atteint 589 : 470 à Isiro (AS Mayogo et Tely), 80 à Pawa et 39 à Wamba (AS Bolebole).

2.6.2. Défis

Accélérer la vaccination des PPL dans les zones prioritaires, particulièrement au Nord-Kivu, Nord-Ubangi assurer la disponibilité des intrants et la surveillance des MAPI, tout en poursuivant l'évaluation scientifique de la protection conférée par le vaccin Ervebo contre la MVE à virus Bundibugyo.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, l'évaluation de base de l'HGR d'Oicha a relevé un triage ne respectant pas le circuit de sécurisation et fonctionnel seulement jusqu'à 17 h, l'absence d'EPI, de poubelles à pédale et de produits d'hygiène, un circuit Ebola non sécurisé au laboratoire, des accouchements de suspects réalisés dans la salle commune et l'absence de plan de suivi des perdus de vue TB et VIH ; à l'HGR de Kyondo, le triage n'est pas conforme, 13 agents sur 33 de la maternité ne sont pas formés en SONU B et CPNr. 25 agents sur 205 (12,2 %) sont formés en PCI et 50 agents sont exposés, dont 5 en quarantaine ;
- **À la Tshopo**, l'évaluation du CP Prison centrale a relevé 121 cas de malnutrition chez les adultes et 10 PVVIH suivis, une rupture d'antituberculeux pour une cohorte de 16 patients, une très mauvaise gestion des déchets, l'absence de zone de triage et aucun agent formé ni vacciné contre la MVE (0/10). Les plans de redressement du CS Alwaleed et du PS militaire Ketele ont été élaborés et le suivi des guéris présentant des complications se poursuit à l'HGR de Makiso-Kisangani ;
- **Au Haut-Uélé**, l'intégration du rattrapage vaccinal des enfants zéro dose et sous-vaccinés et de la surveillance dans le suivi de la distribution des MILD a été plaidée dans les 13 ZS, la formation de 7 cadres de ZS sur la SIMR se poursuit et 5 PPL restent pris en charge dans

les CTE (2 à Wamba, 2 à Pawa et 1 à Boma Mangbetu) ; le déficit de subvention pour la gratuité des soins persiste dans les 7 ZS les plus touchées ;

- **En Ituri**, 79 enfants ont bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle par LNPE/SLM : 9 sur 9 au CTE, 6 sur 6 à la crèche et 64 sur 64 dans la communauté ; l'AMMA, la distribution des MILD et les émanateurs spatiaux ont été lancés et les médicaments pour la gratuité des soins ont été distribués dans les ZS ciblées.

2.7.2. Défi majeur

Garantir la continuité, l'accessibilité et la sécurité des soins essentiels dans les zones affectées, à travers la mise en conformité des circuits de triage et de prise en charge, le renforcement des compétences et de la protection du personnel soignant, la disponibilité des médicaments essentiels et la mobilisation des ressources nécessaires au maintien de la gratuité des soins.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 21 327 visites à domicile ont touché 72 460 personnes ; 460 causeries éducatives ont réuni 10 143 personnes, 72 sensibilisations de masse 4 508 personnes, 7 débats communautaires 331 personnes et 13 plaidoyers 40 autorités religieuses et APA (Rwampara, Komanda, Fataki et Mandima). Au total, 354 alertes communautaires, dont 186 décès, ont été notifiées ; 61 feedbacks sur 79 (77,2 %) et 9 incidents sur 9 (100 %) ont été résolus dans les 48 heures. La CREC a facilité le pré-listage de 152 contacts, la décontamination de 15 ménages sur 15, la réalisation de 32 EDS sur 37 (86,5 %), l'annonce de 12 résultats positifs sur 12 et le transfert de 33 suspects sur 34 au CTE ; la complétude des rapports CREC reste faible (10/28 ZS, 36 %) ;
- **Au Nord-Kivu**, 10 626 visites à domicile ont touché 34 917 personnes, 106 causeries éducatives 2 856 personnes, 57 communications de masse 5 271 personnes et 4 briefings 77 personnes ; 372 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues (57,2 %), 19 feedbacks sur 26 (73,1 %) et 1 incident sur 1 ont été résolus dans les 48 heures et 1 266 personnes sur 4 750 (26,7 %) ont été engagées dans les actions communautaires. Une réunion des partenaires de la CREC, une tribune d'expression populaire à Manguredjipa et un dialogue communautaire avec les prestataires des PoC et les RECO de Beni ont été organisés ;
- **À la Tshopo**, 318 ménages ont reçu des visites à domicile (2 212 personnes), 2 causeries éducatives ont réuni 125 personnes et 11 sensibilisations de masse 11 305 personnes à Lubunga, Kabondo et Makiso-Kisangani, et 2 émissions radio ont été diffusées ; les médecins responsables des ESS privés ont été sensibilisés et engagés sur la MVE, les réunions SGI de 5 ZS ont été appuyées et la sortie d'un guéri du CTE de Météo a été accompagnée de témoignages ; 2 feedbacks sur 2 et 1 refus sur 1 ont été résolus.

2.8.2. Défi majeur

Améliorer la complétude et la qualité des rapports CREC, renforcer la détection et la notification des alertes communautaires, accroître la participation effective des populations et assurer la résolution rapide des préoccupations et réticences, particulièrement dans les foyers actifs de l'Ituri et du Nord-Kivu.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Ituri,** 23 cas confirmés sur 44 (52,3 %), 81 confirmés en cours de suivi sur 126 (64,3 %), 48 nouveaux suspects sur 114 (42,1 %) et 106 suspects en cours de suivi sur 221 (48,0 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 253 accompagnants et 99 PPL, suivi 17 guéris sur 23 (73,9 %) en communauté et 12 enfants sur 12 en crèche, accompagné 11 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 16, réinséré 4 guéris sur 7, réalisé 2 réunifications familiales et annoncé 36 résultats, dont 23 positifs ; 56 enfants sont suivis ;
- **Au Nord-Kivu**, 12 derniers cas confirmés sur 14 (85,7 %), 212 confirmés en cours de suivi, 211 nouveaux suspects et 215 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, les 6 ZS ayant notifié des cas étant couvertes (100 %) ; les équipes ont accompagné 81 ménages et 37 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 40 (92,5 %),

soutenu 55 PPL, suivi 4 enfants sur 4 en crèche et 20 enfants sur 36 (55,5 %) dans la communauté, suivi 7 guéris sur 10 (70,0 %) en communauté, réinséré 11 guéris et annoncé 87 résultats, dont 14 positifs ; 313 personnes (153 hommes, 115 femmes et 45 enfants) ont bénéficié de la psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF ;

- **Au Haut-Uélé**, seules Isiro et Pawa ont rapporté : 1 nouveau cas confirmé, 10 confirmés en cours de suivi, 4 nouveaux suspects et 14 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 36 accompagnants et 40 PPL ont été soutenus, 4 enfants séparés ont été suivis en communauté, 2 EDS ont été appuyés et 13 résultats annoncés, dont 1 positif ; 5 non-cas sont sortis du CTE de Pawa et un enfant suspect de 30 mois a été admis au CTE d'Isiro.

2.9.2. Défis

Assurer une couverture psychosociale systématique des cas confirmés et suspects, renforcer le suivi et la réinsertion des guéris, garantir la protection des enfants séparés et orphelins et améliorer la complétude des données SMSPS, particulièrement en Ituri et au Haut-Uélé.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions.

Assurer la mobilité de toutes les équipes de terrain dans les provinces touchées ; au Nord-Kivu, les travaux de construction des cabanes au PoC PK5 et de la cabane et de la passerelle des voyageurs à l'aéroport de Beni se poursuivent avec l'appui de l'OIM ; au Haut-Uélé, une équipe est descendue à Wamba pour le briefing des prestataires et l'activation des PoC PK18 et Bangwene, l'entretien d'une ambulance de Boma Mangbetu a été suivi, 2 véhicules de la coordination ont été approvisionnés en carburant pour la mission de Bolebole et les intrants de riposte ont été livrés au pilier PoE/PoC ; au Bas-Uélé, la construction du CTE de l'HGR de Buta (cloisonnement des chambres et toilettes) et la réhabilitation des bureaux de la DPS avec l'appui de l'OMS se poursuivent, les équipes de surveillance ont été déployées à Ganga et à Viadana, 2 circuits de dispositifs de lavage des mains ont été installés au PoC PK4 Rive gauche avec un mois d'approvisionnement en eau (appui de FHI360) et les intrants destinés aux ZS en préparation sont en cours de colisage.

2.10.2. Défi majeur

Garantir la mobilité permanente des équipes de terrain, accélérer l'opérationnalisation des infrastructures de riposte et sécuriser l'approvisionnement continu en carburant, équipements et intrants essentiels, particulièrement dans les zones enclavées et les nouveaux foyers épidémiques.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions.

À la Tshopo, des tensions communautaires et un refus de swab ont été signalés à Bafwasende, où les agressions et menaces contre les équipes d'intervention rapide empêchent les investigations autour des cas 65 à 70. Au Haut-Uélé, la sous-coordination de Wamba a été déplacée vers la zone de résistance de Bolebole-Mambati et l'accès à l'église de Réveil Gosene (Isiro), où des alertes ont été signalées, a été refusé aux équipes ; en Ituri, le PoC d'Avakubi demeure non fonctionnel en raison de l'insécurité

2.11.2. Défi majeur

Garantir un accès sûr et continu des équipes de riposte aux zones affectées, particulièrement à Bafwasende, Bolebole–Mambati et Avakubi, en privilégiant le dialogue communautaire, la prévention des incidents sécuritaires et la protection des intervenants, afin d'assurer la continuité des investigations, des prélèvements et de la surveillance épidémiologique.

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri,** 99 participants (46 femmes et 53 hommes), dont des superviseurs RECO, des RECO et des chefs de rue, ont été formés ou briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite dans la ZS de Bunia, où 8 vendeurs ont également été sensibilisés ;

l'affichage des messages et la distribution des dépliants se poursuivent dans les ZS de Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa, Fataki et Mandima. 15 ZS sur 36 (41,7 %) connaissent le mécanisme de signalement ;

- **Au Nord-Kivu,** 28 agents de saisie des données ont été briefés sur la PSEA/HS à Beni, où 47 relais communautaires des équipes ECUMR et 487 membres de la communauté ont été sensibilisés ; des sensibilisations ont également touché 21 personnes à Butembo, 133 membres de la communauté et 29 PRECODESA à Katwa, 23 personnes à Nyiragongo (AS Rusayo), 18 personnes à Mutwanga, 7 prestataires à Mabalako et 7 enseignants à Kalunguta, et 19 membres du comité de gestion des épidémies ont été réunis à Walikale ; 3 partenaires (IMC, WAAR et DRDC) ont rapporté leurs activités

2.12.2. Défis

Etendre la connaissance et l'accessibilité des mécanismes de signalement PSEA/HS à l'ensemble des zones de santé affectées, renforcer la formation et la redevabilité de tous les intervenants et améliorer la coordination ainsi que la complétude des rapports des partenaires, afin de garantir un environnement de riposte sûr et respectueux des droits des populations.

2.13. Gestion des bases des données

2.13.1. Principales actions

- Poursuite de la collecte, de la centralisation, de la vérification et de la consolidation quotidienne des données épidémiologiques et opérationnelles transmises par les provinces affectées, en vue d'assurer la production régulière des SitRep ;
- Poursuite de la mission d'appui technique et de supervision du Chef de pilier Gestion des bases des données à Beni et Butembo, dans la province du Nord-Kivu, en vue de renforcer la qualité, la complétude, la cohérence et la promptitude des données produites par les équipes opérationnelles ;
- Accompagnement des équipes provinciales et des zones de santé dans la vérification et l'harmonisation des bases de données, notamment celles relatives aux cas confirmés, aux décès, aux guérisons, aux suivis des contacts, aux alertes et aux interventions des différents piliers techniques ;
- Renforcement du rapprochement des données entre les équipes de surveillance épidémiologique, de laboratoire, de prise en charge et de gestion de l'information, afin de réduire les discordances entre les bases individuelles, les rapports journaliers et les données consolidées ;
- Appui à l'identification et à la correction des doublons, des données manquantes et des incohérences, particulièrement dans les zones de santé se trouvant sur les axes de Beni et de Butembo, en vue d'améliorer la fiabilité des indicateurs utilisés pour la prise de décision ;
- Poursuite de l'encadrement technique des gestionnaires des données et des points focaux des piliers, avec un accent sur le respect des procédures de validation, l'utilisation harmonisée des outils de collecte et la transmission des rapports dans les délais requis ;
- Renforcement de la coordination entre le niveau national, les Divisions provinciales de la santé et les équipes des zones de santé pour améliorer la circulation de l'information, la traçabilité des corrections et la disponibilité de données fiables.

2.13.2. Défi majeur

Capitaliser sur la mission du Chef de pilier à Beni et Butembo pour renforcer durablement le dispositif provincial de gestion des données, harmoniser les bases des différents piliers, corriger les incohérences et garantir la production quotidienne de données complètes, fiables et validées, indispensables au pilotage stratégique.

MESSAGES CLES

- La riposte contre la 17e épidémie de maladie à virus Ebola en RDC enregistre des progrès encourageants sur le plan épidémiologique et opérationnel. Au cours des dernières 24 heures, 40 nouveaux cas confirmés ont été notifiés, contre 67 la veille et 64 le 10 octobre 2026, soit une réduction respective de 40,3 % et 37,5 %. Les décès communautaires ont également diminué, passant de 18 la veille à 9, soit une réduction de 50,0 %. Aucune nouvelle zone de santé n'a été affectée au cours de la journée.
- Sur le plan de la surveillance épidémiologique, 450 cas suspects sur 458 (98,3 %) ont été investigués, tandis que le taux de suivi des contacts a progressé de 79,1 % à 80,0 %. Ces avancées traduisent les efforts des équipes de terrain. Toutefois, huit cas suspects restent à investiguer dans la zone de santé de Rwampara, en Ituri, et le suivi des contacts demeure inférieur à la cible opérationnelle de 95,0 %.
- Le diagnostic biologique montre également une évolution favorable, avec un taux de positivité de 9,7 %, contre 14,4 % le 10 octobre, soit une baisse de 4,7 points de pourcentage. Par ailleurs, 8 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant le cumul à 2 530 personnes guéries. Néanmoins, les 16 décès enregistrés dans les CT/CTE, contre 8 la veille, rappellent la nécessité de renforcer la prise en charge précoce et les soins aux patients présentant des formes graves.
- Pour la Coordination nationale de la riposte, les efforts doivent se poursuivre pour consolider ces acquis, notamment à travers le renforcement de la surveillance et du suivi des contacts, l'intensification des interventions PCI/EDS et CREC, l'amélioration des capacités d'accueil et de la qualité des soins dans les CT/CTE, ainsi que la mobilisation des partenaires pour une riposte rapide au Nord-Ubangi.
- La priorité demeure l'interruption des chaînes de transmission, la réduction des décès évitables et la protection des populations, tout en maintenant une vigilance élevée dans l'ensemble des provinces affectées.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.